SDD 14 Sujet n°1

Spécialité : Réanimation

Date : Octobre 2024
Auteur : Marin CAUMARTIN (DES MIR)
Relecteur(s) : Sarah BUTTAZZONI (DES AR), Mathilde DELPY (DES AR), Sébastien VILLARD (DES MIIC)

Domaine d'apprentissage principal	Urgence vitale
Domaine d'apprentissage secondaire	Examen clinique
Item(s) en lien avec la station	205. Hémoptysie
Situation(s) de départ en lien avec la station	14. Emission de sang par la bouche
Matériel nécessaire à la station	/
Contexte de la station	Hospitalisation

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :
Vous êtes interne des étages et êtes appelé par l'équipe paramédicale de nuit du service de chirurgie thoracique pour Monsieur D. 62 ans, qui vient de cracher du sang.
Vous vous rendez à son chevet, les paramètres vitaux sont alors :

- Fréquence cardiaque 129/min
- Saturation pulsée en O2 (sous 3 L/min aux lunettes) 89%
- Pression artérielle au brassard : 139 mmHg / 86 mmHg
- Température 37.2°C
- Glycémie 7.2 mmol/L ou 1.31 g/l

Vous ne connaissez pas son dossier médical. Son électrocardiogramme réalisé par vos soins montre une tachycardie sinusale sans autres anomalies en dehors de la fréquence. Vous vous adressez au patient.

Consignes :
Vous devez réaliser en 7 minutes

- Un interrogatoire et un examen clinique ciblé
- Enoncer un diagnostic et un stade de gravité
- Décider du devenir du patient pour la suite de la prise en charge

Vous ne devez pas :

- Prescrire d'examens complémentaires
- Prescrire de traitement, débuter une prise en charge thérapeutique

Attention : Vous avez 8 minutes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

ECOS TACFA
GRILLE D'EVALUATION

Consigne(s) à l'évaluateur :

Aptitudes cliniques			
1.	Recherche les antécédents médicaux / chirurgicaux du patient	1 pt	☐
2.	Demande le traitement actuel ou recherche spécifique d'un traitement anticoagulant	1pt	☐
3.	Recherche l'administration ou la prise d'un traitement anticoagulant	1 pt	☐
4.	Recherche un geste chirurgical ou endoscopique récent	1 pt	☐
5.	Demande de la fréquence respiratoire	1 pt	☐
6.	Demande si l'émission de sang précédait bien **un effort de toux**	1 pt	☐
7.	Quantifie l'hémoptysie : rempli une cuillère (ou faible), rempli un crachoir (ou moyenne) ou rempli un haricot (ou grande abondance)	1 pt	☐
8.	Recherche de signes d'hypoperfusion périphérique (marbrures des membres inférieurs, pouls filants des extrémités, extrémités froides)	1 point si au moins 2 cités	☐
9.	Recherche de signes de lutte respiratoires (polypnée, tirage intercostal ou susclaviculaire, expiration abdominale active)	1 point si au moins 2 cités	☐
10.	Recherche des signes de faillite respiratoire : pause respiratoire, cyanose, expiration abdominale active	1 point si au moins 2 cités	☐
11.	Recherche de signes d'hypercapnie : sueurs, flapping, hyperhémie conjonctivale, troubles de la conscience	1 point si 1 demandé	☐
12.	Auscultation pulmonaire bilatérale	1 pt	
13.	Auscultation des 4 valves cardiaques	1 pt	
14.	Pose le diagnostic d'hémoptysie grave et de moyenne abondance	1 pt	☐
15.	Indique un transfert en réanimation ou appelle le réanimateur de garde	1 point	
Communications et attitudes			

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

2. APTITUDE À QUESTIONNER

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Pose des questions fermées ou trop directives ou qui ne répondent pas aux objectifs Utilise le jargon médical	Pose des questions qui s'éloignent des objectifs Utilise quelques fois un jargon médical sans explication	Utilise différents types de questions couvrant les éléments essentiels Utilise quelques fois un jargon médical mais toujours avec explications	Pose des questions précises couvrant la plupart des éléments avec quelques omissions mineures Utilise le langage approprié	Pose les questions avec assurance et savoir-faire

4. APTITUDE À STRUCTURER/ MENER L'ENTREVUE

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Approche désordonnée	Entrevue peu structurée, présente les difficultés à recadrer les discussions qui s'éloignent des objectifs	Entrevue centrée sur le problème et couvre les éléments essentiels	Entrevue menée de façon logique, structurée, centrée sur le problème, ne cherche pas l'information non pertinente	Entrevue ayant un but précis, approche intégrée

9. APTITUDE À STRUCTURER L'EXAMEN CLINIQUE

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
L'examen clinique est incomplet et désorganisé ou ne fait pas l'examen clinique	Les éléments recherchés sont peu ciblés, s'attarde à des manœuvres inutiles	L'examen clinique est raisonnablement organisé et couvre les éléments essentiels	L'examen clinique suit un enchaînement logique et est centré sur le problème, il n'y a pas de manœuvre inutile	L'examen est réalisé sans erreur avec un but précis, démarche intégrée

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

8. APTITUDE À FAIRE LA SYNTHÈSE DES DONNÉES

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
N'arrive pas à faire ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème	Fait ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème quelquefois sans les justifier	Fait ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème et justifie son raisonnement	Fait ressortir les éléments positifs et négatifs pour clarifier le problème et justifie son raisonnement	Agit avec assurance et sans erreur

10. APTITUDE À MENER L'EXAMEN CLINIQUE

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
N'explique pas au patient les gestes réalisés ou ne respecte pas le confort du patient	Explique peu les gestes réalisés	Explique les gestes réalisés et respecte le confort du patient	Donne l'information sur les gestes en expliquant les objectifs /les éléments recherchés et respecte le confort du patient	Agit sans erreur Met à l'aise

TOTAL (max 20 items)	19 points

Éléments de rétroaction :

Ici nous sommes devant une détresse respiratoire sur hémoptysie de moyenne abondance avec retentissement respiratoire sévère.
Il est important de retenir que la gravité d'une hémoptysie se constate sur le retentissement respiratoire et non sur l'aspect hémorragique avec privation sanguine. Le patient est ici en train de se noyer dans son propre sang (on estime le volume libre des voies aériennes inférieures à 200 ml)
La situation est d'autant plus grave qu'il s'agit d'un patient sous anticoagulation curative dans un contexte post endoscopique.
Ce patient nécessite un monitoring en continu, une adminsitration d'oxygène à débit élevés voire une ventilation mécanique

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

ECOS TACFA

SCÉNARIO PATIENT SIMULÉ

Consignes génériques pour le patient :

- Ce que tu peux dire spontanément ou sous condition est clairement indiqué
- Si le candidat pose une question dont la réponse ne se trouve pas dans le scénario, n'improvise pas et réponds « je ne sais pas » ou « c'est normal ».

Rappel du scénario du candidat :

Il s'agit de monsieur D, 62 ans.
Il est hospitalisé depuis ce jour en programmé pour une biopsie d'une adénopathie bronchique dans un contexte de découverte récente (il y a 10 jours) d'un cancer pulmonaire probablement multimétastatique (ganglions, os, cerveaux, foie, plèvre). On lui a également découvert une embolie pulmonaire proximale, sous anticoagulation curative.
Il est également hypertendu, son état général est conservé, il n'a pas d'allergies médicamenteuses.
Son traitement quotidien comporte :

- Enalapril/Lercanidipine 20 mg le matin
- ENOXAPARINE 7000 UI toutes les 12 heures
- Paracétamol 1000 mg et Néfopam 20 mg sur douleurs osseuses

Il a présenté deux épisodes d'hémoptysie pendant cette nuit d'environ deux crachoirs à chaque fois, a souillé les draps. Il se sent oppressé depuis une vingtaine de minutes, il a l'impression d'étouffer.

Plan de la station ECOS :

Patient simulé sur un brancard/lit, face au candidat. Il est allongé en position ½ assise

<u>Phrase de démarrage du patient simulé (par <3) :</u>

"Docteur, je me sens mal j'ai du mal à respirer"

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

Identité du patient :

Monsieur D, 62 ans
170 cm pour 65 kg

Mode de vie :

Ancien professeur de mathématiques, à la retraite
Tabagisme sevré 40 PA depuis 2 ans
Consommation alcool occasionnelle pas plus de 2 verres à chaque occasion
Pas d'allergies médicamenteuse
Autonome à domicile, vit avec son épouse. A deux fils d'une trentaine d'année chacun

Comportement global :

Patient agité, en sueurs, polypnéique avec FR = 35-40 /min
A rempli deux crachoirs de sang
Lunettes à O2 sous 3 L/min

Antécédents personnels :

Hypertension artérielle
Découverte récente (10 jours avant) d'un probable cancer pulmonaire multimétastatique (ganglions, plèvre, vertèbres, encéphale), avec découverte concomitante d'une embolie pulmonaire proximale

Antécédents familiaux :

0

Médicaments :

Traitement de fond : Enalapril/Lercanidipine

Traitement ajouté depuis 10 jours :
L'ENOXAPARINE a été suspendue la veille de la chimiothérapie, et a été ré introduite 2 heures après la réalisation d'endoscopie bronchique avec biopsies d'adénopathies

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

Symptômes positifs :

Polypnéique 35-40/min, sans temps expiratoire ou inspiratoire
Toux grasse avec hémoptysie
Oppression médiothoracique

Si le candidat le demande : le patient ne présente pas de signes d'hypoperfusion hémodynamique, présente une polypnée avec tirage susclaviculaire et intercostal, mais ne présente pas (encore) de cyanose ou de balancement thoracoabdominale. Il présente des sueurs diffuses.
Pas de troubles de la conscience. Le patient n'est pas confus.

A l'examen clinique vous pouvez trouver un reflux hépatojugulaire et une turgescence jugulaire spontanée.
L'auscultation retrouve des bruits du coeur réguliers sans souffle perçu, et un murmure vésiculaire bilatéral et symétrique avec ronchis diffus.

Le reste de l'examen est sans particularité

Paramètres vitaux :

- Fréquence cardiaque 129/min
- Saturation pulsée en O2 (sous 3 L/min aux lunettes) 89%
- Pression artérielle au brassard : 139 mmHg / 86 mmHg
- Température 37.2°C
- Glycémie 7.2 mmol/L ou 1.31 g/l
- Fréquence respiratoire : 35-40 /min

Questions de relance :

Si le candidat n'a pas formulé de diagnostic à 5 minutes, lui demander
Si le candidat n'a pas énoncé de devenir / demande d'avis spécialisé à 6 minutes, lui demander s'il compte laisser le patient en salle de chirurgie

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)